

CARTILHA DE PSICOLOGIA INFANTIL

Cuidar das emoções também é desenvolvimento





Psicologia Infantil: cuidado, escuta e desenvolvimento

Esta cartilha apresenta, de forma acessível, como a Psicologia pode contribuir durante a infância. O material foi pensado para familiares, educadores e profissionais que desejam interpretar melhor determinados sinais e tomar decisões mais seguras.

Nos primeiros anos, grande parte do que a criança vive aparece antes no corpo e nas atitudes do que na fala. Mudanças no sono, no brincar, nas relações ou no rendimento podem ser maneiras de mostrar que algo precisa de atenção.

O trabalho psicológico organiza essas informações, investiga o que sustenta a dificuldade e define caminhos possíveis. Conversas, histórias, desenhos e jogos são escolhidos conforme a idade e a finalidade clínica; não funcionam como atividades soltas.

Ao lado de Ray, Ritinha percorre as principais etapas desse processo: desenvolvimento afetivo, sinais de alerta, avaliação, planejamento terapêutico, participação dos adultos e princípios éticos. Ao final, alguns mitos frequentes são esclarecidos.

Como utilizar este material

Leia as seções em sequência: primeiro, observe como sentimentos e comportamentos se relacionam; depois, veja quando buscar orientação e como o trabalho clínico é organizado. Os quadros destacam critérios práticos para o cotidiano.



Aprender a reconhecer o que sente

O repertório emocional se constrói nas experiências diárias. Ao esperar a vez, perder um jogo, separar-se de uma pessoa importante ou enfrentar uma novidade, a criança aprende gradualmente a identificar o que acontece dentro dela e a responder ao ambiente.

Na ilustração, Ritinha escolhe um cartão que representa tranquilidade. Ray oferece pistas, mas não entrega a resposta. A cena mostra um princípio importante: o adulto funciona como apoio temporário até que a criança consiga utilizar seus próprios recursos.

Tristeza, medo, raiva e frustração não são falhas a serem eliminadas. Cada estado traz informações sobre desejos, limites, ameaças ou perdas. A dificuldade surge quando a reação se torna desproporcional, permanece por muito tempo ou impede atividades importantes.

Esse aprendizado reúne quatro capacidades: perceber sensações, dar significado ao que aconteceu, comunicar-se de modo possível e recuperar-se depois de uma situação difícil. Elas amadurecem em ritmos diferentes e dependem da qualidade das relações e das oportunidades oferecidas.

RECONHECER

Perceber sensações, nomear emoções e relacioná-las aos acontecimentos.

EXPRESSAR

Comunicar o que sente com palavras, gestos, brincadeiras ou outros recursos.

REGULAR

Reduzir a intensidade da reação e escolher respostas mais seguras.

Emoções, comportamento e cotidiano

Antes de dominar a linguagem, a criança se comunica pelo olhar, pelo choro, pelos movimentos e pela aproximação ou recusa. Mesmo depois que começa a falar, o brincar, o desenho e as alterações de conduta continuam revelando aspectos que ela ainda não consegue explicar.

As emoções cumprem funções distintas. O medo favorece proteção; a tristeza acompanha despedidas e perdas; a raiva mobiliza reação diante de limites ou injustiças; a alegria aproxima pessoas e reforça experiências positivas. Nenhuma delas, isoladamente, define um problema.

Nos momentos de maior intensidade, o sistema nervoso infantil ainda depende do adulto. Um tom de voz estável, limites claros e a presença disponível ajudam a reduzir a ativação. Só depois disso costuma ser possível conversar sobre o ocorrido e pensar em alternativas.

Esse apoio é chamado de correção. Com a repetição, estratégias que antes dependiam do adulto passam a ser usadas com mais autonomia: pedir uma pausa, buscar ajuda, negociar, respirar ou retomar uma atividade.

A meta não é obediência permanente nem calma artificial. É ampliar flexibilidade, participação social e capacidade de reparar conflitos sem apagar o temperamento e a singularidade.

Da correção à autonomia

Primeiro o adulto oferece estabilidade, organiza o ambiente e nomeia o que ocorreu. Depois, convida a criança a participar da solução. Com o tempo, diminui a ajuda e amplia a responsabilidade compatível com a idade.

Quando observar com mais atenção

Nem toda mudança exige terapia. O primeiro passo é verificar se existe um padrão. Um episódio após uma noite mal dormida tem peso diferente de reações que se repetem durante semanas e começam a limitar a vida da criança.

Merecem atenção: agressividade recorrente; medos que impedem atividades; isolamento; perda de interesse pelo brincar; alterações prolongadas no sono ou na alimentação; choro frequente; separações muito difíceis; regressões e queda acentuada na participação escolar.

Quatro perguntas ajudam a organizar a observação: há quanto tempo começou? Com que frequência acontece? Qual é a intensidade? Que prejuízo provoca? A combinação dessas respostas orienta melhor do que qualquer sinal isolado.

Também é válido buscar orientação em períodos de transição: mudança de escola, separação familiar, luto, chegada de um irmão ou diagnóstico de saúde. Uma conversa precoce pode organizar os adultos e evitar que dificuldades previsíveis se agravem.

A consulta inicial não produz, por obrigação, um diagnóstico. Ela pode resultar em recomendações para casa, contato com a escola, encaminhamento a outra especialidade, acompanhamento por período definido ou apenas monitoramento.

Quando houver suspeita de violência, autoagressão, abuso, negligência ou ameaça à integridade, a prioridade muda. A proteção vem antes da investigação prolongada e deve envolver a rede responsável.

Faça um registro simples

Durante uma ou duas semanas, anote situação, reação, duração e consequência. Esse registro ajuda a perceber gatilhos, horários críticos e respostas adultas que aliviam ou prolongam o episódio.

Procure ajuda imediata quando houver risco

Falas ou comportamentos de autoagressão, violência, abuso, negligência, ameaça à integridade ou sofrimento intenso exigem proteção e acionamento da rede adequada. Nesses casos, não se deve aguardar que a situação “passe sozinha”.

O brincar com intencionalidade clínica

Brincar é a linguagem mais espontânea da infância. Ao criar personagens, repetir cenas ou inventar regras, a criança ensaia situações reais em um espaço no qual pode experimentar sem sofrer as mesmas consequências do cotidiano.

Na clínica, a escolha do material responde a uma pergunta. Um jogo com regras pode mostrar como ela espera, negocia e reage ao erro. Bonecos podem facilitar narrativas familiares. Desenhos ajudam a iniciar assuntos para os quais ainda faltam palavras.

O valor não está no brinquedo, mas na leitura que a psicóloga faz da atividade e nas intervenções que realiza: formular perguntas, mudar uma regra, sustentar uma pausa, oferecer linguagem ou convidar a criança a tentar outra solução.

Quando Ritinha perde uma partida, por exemplo, Ray não tenta convencê-la de que perder é bom. Primeiro sustenta a pausa. Em seguida, ajuda a colocar a irritação em palavras e combina uma forma possível de continuar.

Nem toda sessão será divertida. Esperar, rever uma escolha ou falar sobre algo difícil pode produzir desconforto. A diferença é que esse esforço ocorre em uma relação protegida, com limites e objetivos claros.

A mesma brincadeira pode ter finalidades diferentes. Por isso, não existe uma lista universal de atividades terapêuticas. O planejamento depende do caso e é revisto conforme as respostas observadas.

Recurso e finalidade

Jogar é o recurso. Esperar a vez, sustentar a frustração, negociar regras e retornar após um erro são possíveis finalidades. Essa distinção evita que a sessão seja confundida com recreação.

O que não caracteriza intervenção

Ocupar o tempo, entreter sem propósito, impor obediência, prometer resultados rápidos ou aplicar a mesma atividade para todas as crianças sem relação com a demanda.



Compreender antes de intervir

Avaliar é organizar uma investigação com início, perguntas definidas e devolutiva. A psicóloga parte do motivo da busca, reconstrói a história da dificuldade e verifica como ela aparece em diferentes ambientes.

Os encontros permitem observar linguagem, atenção, flexibilidade, estratégias para resolver problemas, qualidade das relações e reação às regras. Na cena, Ritinha se irrita ao perder; essa resposta gera uma hipótese, não uma conclusão.

A hipótese precisa ser comparada com outras informações: relatos familiares, trajetória escolar, acontecimentos recentes e desempenho em tarefas adequadas à idade. Contradições também são relevantes e devem ser explicadas.

O resultado esperado é uma formulação útil: o que está acontecendo, quais fatores mantêm a dificuldade, quais recursos já existem e qual decisão faz sentido naquele momento.

1. DEMANDA

O que motivou a busca

2. CONTEXTO

Onde e quando acontece

3. RECURSOS

O que a criança já consegue

4. DECISÃO

Qual cuidado é indicado

Como acontece a avaliação psicológica

O percurso geralmente começa com uma entrevista com os responsáveis. Nela são definidos o motivo da procura, as perguntas que precisam ser respondidas e os acontecimentos relevantes da história familiar, escolar e de saúde.

Depois, a psicóloga planeja encontros compatíveis com a idade e a linguagem da criança. Observação, conversa, desenho, histórias e jogos permitem conhecer seu modo de funcionar sem exigir respostas que ela ainda não consegue formular.

Testes podem ser incluídos quando acrescentam dados à investigação. Devem possuir respaldo técnico, ser adequados à finalidade e ser usados por profissional qualificado. Um resultado numérico nunca deve ser interpretado sozinho.

Com autorização, a escola e outros profissionais podem informar como a dificuldade aparece fora do consultório. Diferenças entre os ambientes ajudam a identificar demandas específicas, gatilhos e apoios que já funcionam.

Na etapa final, a devolutiva apresenta respostas às perguntas iniciais, limitações do processo e recomendações. Pode indicar psicoterapia, orientação parental, ajustes escolares, encaminhamento ou nova observação após determinado período.

Um bom documento não reduz a criança a um rótulo. Ele descreve o funcionamento atual, aponta recursos e dificuldades e relaciona as recomendações aos dados coletados.

ENTREVISTAS

História do desenvolvimento, saúde, relações, rotina, escola, mudanças recentes e expectativas da família.

ENCONTROS

Observação, conversa e atividades compatíveis com idade, linguagem e condições de participação.

INTEGRAÇÃO

Análise conjunta de dados, hipóteses, fatores de proteção, dificuldades e impacto funcional.

Uma avaliação precisa responder a uma pergunta

Sem uma questão clara, o processo pode acumular informações sem produzir direção. A finalidade define quais fontes serão consultadas, quais procedimentos serão utilizados e como os resultados serão comunicados.

Intervenção e objetivos terapêuticos

Com a formulação do caso pronta, começa o planejamento terapêutico. As prioridades são escolhidas pelo impacto na vida diária e pelo que pode produzir ganhos relevantes naquele momento, evitando trabalhar muitas metas ao mesmo tempo.

Os objetivos devem indicar uma mudança observável. “Lidar melhor com a frustração” é amplo; “pedir uma pausa e retornar à tarefa com menos ajuda” permite acompanhar progresso e ajustar a estratégia.

Conversas, jogos, histórias, atividades expressivas e treino de habilidades são meios. A escolha depende da abordagem da profissional, da faixa etária e do vínculo construído. A técnica precisa servir ao objetivo, e não o contrário.

Parte do trabalho ocorre com os adultos. Alterar rotinas confusas, antecipar transições, reduzir exigências incompatíveis ou responder de forma mais consistente pode diminuir dificuldades sem responsabilizar exclusivamente a criança.

O plano é revisto periodicamente. Evolução não significa ausência de recaídas, mas mudança de tendência: episódios menos frequentes ou intensos, recuperação mais rápida, maior iniciativa e uso das habilidades em outros ambientes.

Do objetivo amplo ao objetivo observável

Troque “melhorar o comportamento” por uma descrição concreta: diante de uma mudança de atividade, utilizar a estratégia combinada e iniciar a nova tarefa com até uma orientação do adulto.

Quatro marcadores de progresso

Menor frequência, menor intensidade, recuperação mais rápida e menor dependência de ajuda. O avanço deve aparecer na vida cotidiana, não apenas dentro do consultório.

Família, escola e sigilo profissional

Os responsáveis ajudam a reconstruir a história, testam orientações no cotidiano e informam o que mudou fora do consultório. Sua participação é planejada conforme a idade da criança e os objetivos definidos.

Participar não significa receber um relato completo de cada sessão. A privacidade permite que a criança fale e brinque sem sentir que todo conteúdo será reproduzido. Aos adultos chegam as informações necessárias para decisões e proteção.

Se surgir risco relevante, a psicóloga avalia o que precisa ser comunicado e quais medidas devem ser tomadas. O atendimento não eventual de crianças exige autorização de ao menos um responsável legal.

A escola oferece dados sobre aprendizagem, convivência, transições e participação em grupo. O contato precisa ter propósito definido, autorização e troca restrita ao que é pertinente.

Quando há outros atendimentos, uma comunicação objetiva evita orientações incompatíveis e duplicação de metas. Cada área preserva seus limites e responde pelo próprio trabalho.

Adultos não precisam concordar sobre todas as interpretações. Precisam compartilhar prioridades, combinar respostas consistentes e avaliar se as mudanças adotadas estão produzindo benefício real.

FAMÍLIA

Compartilha informações, recebe orientação e cria condições para a criança praticar novas habilidades no cotidiano.

ESCOLA

Contribui com dados funcionais e adapta estratégias quando isso é pertinente e autorizado.

PSICÓLOGA

Integra informações, preserva o sigilo, define limites técnicos e comunica apenas o necessário ao cuidado.

Sigilo não é segredo absoluto

A privacidade sustenta o vínculo terapêutico. Aos responsáveis são comunicadas informações necessárias para decisões de cuidado. Em situações de risco ou proteção, a profissional avalia as medidas cabíveis conforme a ética e a legislação.



Informação também transforma

Dúvidas sobre Psicologia Infantil costumam misturar experiências pessoais, expectativas escolares e informações das redes sociais. O resultado pode ser atraso na busca por ajuda ou expectativa de soluções que a clínica não promete.

O trabalho não se limita a produzir diagnósticos nem a fazer a criança obedecer. Também não consiste em deixá-la brincar livremente durante toda a sessão. Há perguntas clínicas, método, registro, limites éticos e revisão de resultados.

Ray e Ritinha organizam os cartões entre mito e verdade. Nas próximas páginas, cada afirmação recebe uma resposta curta e uma justificativa, para que o leitor diferencie sinais relevantes de conclusões precipitadas.

A regra central é simples: afirmações absolutas raramente descrevem bem a infância. Idade, história, ambiente e prejuízo funcional mudam o significado de uma mesma conduta.

Como reconhecer uma simplificação

Desconfie de frases que usam “sempre”, “nunca” ou prometem uma explicação única. Uma afirmação confiável informa limites, considera alternativas e relaciona a conclusão aos dados disponíveis.

O que precisamos esclarecer

MITO

A criança só precisa de psicólogo quando apresenta um problema grave.

O acompanhamento também pode apoiar mudanças, dificuldades emocionais, conflitos e necessidades de orientação.

VERDADE

Brincar pode fazer parte do acompanhamento.

Jogos e atividades simbólicas permitem observar estratégias, iniciar conversas e ensaiar respostas novas.

MITO

Irritação ou desobediência significam que existe um transtorno.

Uma conduta pode refletir cansaço, limites inconsistentes, dificuldade de comunicação, mudanças recentes ou diversos outros fatores.

VERDADE

A família participa do processo.

Os adultos ajudam a definir prioridades, aplicam combinações no cotidiano e informam se houve mudança fora da sessão.

MITO

Existe uma técnica única que funciona para toda criança.

Método, linguagem e ritmo precisam ser ajustados à pergunta clínica, à faixa etária e à resposta observada.

Cuidado sem culpa e sem rótulos

MITO

O psicólogo conta aos responsáveis tudo o que a criança fala.

O profissional comunica o necessário ao cuidado e à proteção, preservando a privacidade da criança.

VERDADE

O ritmo de aquisição varia entre crianças.

Variação é esperada, mas não deve ser usada para ignorar perda de habilidades, sofrimento ou prejuízo persistente.

MITO

Buscar ajuda significa que os responsáveis falharam.

Pedir uma avaliação é uma decisão de responsabilidade e pode reduzir culpa, conflito e tentativas improvisadas.

VERDADE

Nem toda avaliação termina em diagnóstico.

A conclusão pode indicar orientação breve, psicoterapia, encaminhamento, ajuste ambiental ou observação planejada.

MITO

O resultado depende apenas da criança.

Rotina, relações, exigências e respostas dos adultos podem manter ou reduzir a dificuldade e também entram no plano de trabalho.

QUANDO BUSCAR ORIENTAÇÃO

Procure avaliação quando mudanças forem intensas, persistentes, inesperadas ou produzirem prejuízo relevante na rotina, nos vínculos, na aprendizagem ou no bem-estar. A busca não determina automaticamente um diagnóstico.



Sentir não é errado

A Psicologia Infantil transforma observações dispersas em perguntas mais precisas. Em vez de concluir rapidamente que a criança é “difícil”, investiga-se o que mudou, em quais situações a reação aparece e o que já ajuda.

Quando há indicação de tratamento, o plano conecta a sessão à vida real. Habilidades praticadas no consultório precisam melhorar participação, relações, autonomia ou bem-estar fora dele.

Familiares, escola e equipe clínica têm funções diferentes. A qualidade do trabalho aumenta quando cada parte sabe o que observar, o que comunicar e quais limites deve preservar.

Os melhores resultados não vêm de eliminar toda reação difícil, mas de reduzir prejuízos, ampliar escolhas e tornar a recuperação mais rápida e menos dependente do adulto.

A jornada de Ray e Ritinha termina com uma ideia prática: sentimentos não precisam comandar todas as ações, mas precisam ser reconhecidos para que novas respostas se tornem possíveis.

O que os adultos podem fazer no cotidiano

Descrever o que observaram sem rotular; manter limites previsíveis; oferecer duas alternativas possíveis; conversar depois que a intensidade diminuir; reparar o vínculo após conflitos; e registrar mudanças persistentes.

Mensagem final

A meta não é uma infância sem conflitos. É uma criança capaz de pedir ajuda, experimentar alternativas, recuperar-se de situações difíceis e participar da vida com mais segurança.

Referências bibliográficas

- BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente.
- CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Código de Ética Profissional do Psicólogo. Resolução CFP nº 010/2005.
- CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Resolução CFP nº 13, de 15 de junho de 2022. Diretrizes e deveres para o exercício da psicoterapia.
- CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Resolução CFP nº 31, de 15 de dezembro de 2022. Diretrizes para a realização de avaliação psicológica e regulamentação do SATEPSI.
- CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Cartilha Avaliação Psicológica. 2ª edição. Brasília: CFP, 2022.
- BEE, Helen; BOYD, Denise. A criança em desenvolvimento. 12ª edição. Porto Alegre: Artmed, 2011.

Ficha técnica

Elaboração editorial: SoulKids

Coordenação e revisão técnica: Raynise Lopes - Psicóloga - CRP 05/67001

Pós-graduação em Análise do Comportamento Aplicada - ABA

Formação em Neuromodulação

Curso de Manejo de Crises em Crianças com Transtorno do Espectro Autista - TEA

Apresentação: Ray e Ritinha

Projeto gráfico e diagramação: SoulKids

Edição: 2026

Nota editorial

Este material possui finalidade educativa e não substitui avaliação psicológica, diagnóstico ou acompanhamento individual. As decisões clínicas devem considerar a história, as condições atuais e as particularidades de cada pessoa atendida.

SENTIR COMPREENDER CRESCER



Raynise Lopes

Psicóloga - CRP 05/67001

Pós-graduação em ABA

Formação em Neuromodulação

Manejo de Crises em Crianças com TEA

**“Toda emoção pode ser compreendida
e cuidada.”**

Conteúdo educativo sobre Psicologia Infantil

SOULKIDS • CUIDADO E DESENVOLVIMENTO